پاسخنامه فصل سوم

۱. گزینه د

در پالپیت برگشت‌پذیر hyperemia (پرخونی) دیده می‌شود و در پالپیت غیرقابل برگشت احتقان وریدها (congestion) دیده می‌شود.

۲. گزینه الف

۳. گزینه الف

کلسیفیکاسیون پالپی در قسمت تاجی و ریشه‌ای شایع‌اند.

۴. گزینه د

۵. گزینه د

عوامل موثر شامل اتریشن ـ شکستگی ـ اروژن ـ ابرژن ـ پوسیدگی بیماری پریودنتال ـ آسیب مکانیکی ناشی از اعمال دندانپزشکی و تحریک ناشی از مواد دندانی می‌باشد.

۶. گزینه الف

کلسیفیکاسیون‌های پالپی با افزایش سن، مصرف مکمل‌های فلورایـد، هایپرویتامینوز D و dentin dysplasia II افزایش می‌یابد.

۷. گزینه د

۸. گزینه ب

۹. گزینه د

۱۰. گزینه ب

۱۱. گزینه ج

Scanned with CamScanner

۱۲. گزینه د

۱۳. گزینه ج

دندان به تست الکتریکی با جریان پایین‌تری پاسخ می‌دهد

۱۴. گزینه ج

معمولا لقی و حساسیت به دق وجود ندارد و در صورت درناژ علائم متوقف می‌شود به پالپ تستر با درجات بالاتری پاسخ می‌دهد یا اصلا پاسخ نمی‌دهد

۱۵. گزینه الف

شایع‌ترین دندان‌های مبتلا به pulp polyp مولرهای دائمی و شیری‌اند

۱۶. گزینه الف

آسیب تروماتیک باعث انسداد زودرس اتاقک پالپ و کانال در دندان مبتلا می‌شود که باعث تغییر رنگ زرد دندان می‌گردد و موسوم به calcific metamorphosis می‌باشد.

۱۷. گزینه ج

۱۸. گزینه ب)

عاج ثانویه‌ای که در پاسخ به آسیب موضعی خفیف تا متوسط ساخته می‌شود را عاج ثالثیه Reactionary می‌نامند که منظم بوده و در ادامه توبولهای دنتین اولیه و ثانویه می‌باشد

۱۹. گزینه د

۲۰. گزینه ج

۲۱. گزینه الف

در آنژین لودویک گسترش عفونت به فضای تحت فکی نمای bull neck را ایجاد می‌کند

۲۲. گزینه ب

آنژین لودویک بیشتر به علت عفونت مولر پایین ایجاد می‌شود

Scanned with CamScanner

۲۳.گزینه د

عوامل مستعد کننده استئومیلیت چرکی شامل بیماری سیستمیک مزمن، ضعف ایمنی کاهش عروق استخوان مانند استئوپتروز، اواخر پاژت و مرحله نهایی سمنتواسئوس دیسپلازی. مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر، دیابت، تب‌های اگزانتوماتوز، مالاریا ، آنمی و سوء تغذیه می‌باشد

۲۴.گزینه د

با بیماری پاژت و فلورید سمنتواسئوس دیسپلازی قابل اشتباه است

۲۵.گزینه د

در Diffuse sclerosing osteomyelitis کشت میکروبی مثبت است و اکثراً Eikenella corrodens می‌باشد. بهترین درمان آن حذف کانون عفونی مجاور است

۲۶.گزینه ج

۲۷.گزینه د

سندرم SAPHO و Chronic recurrent multifocal osteomyelitis مشابه primary chronic osteo-myelitis می‌باشند اما تظاهرات خارج فکی نیز دارند

۲۸.گزینه د

علائم کلاسیک Chronic tendoperiostitis شامل درد راجعه، تورم گونه و تریسموس می‌باشد

۲۹.گزینه د

در کودکان و بالغین جوان دیده می‌شود

۳۰. گزینه ج

۳۱. گزینه د

۳۲.گزینه ب

۳۳. گزینه الف

Scanned with CamScanner

۳۴. گزینه ج

۳۵. گزینه د

۳۶.گزینه د

۳۷. گزینه ج

نمای رادیوگرافی کیست پری اپیکال از گرانولوم پری اپیکال غیرقابل افتراق است در pocket cyst به دلیل حضور انتهای ریشه یک کیسه کامل وجود ندارد.

۳۸. گزینه د

اکثر آبسه‌ها سمت باکال را پرفوره می‌کنند اما لترال ماگزیلا، ریشه پالاتال مولر و مولر دوم و سوم مندیبل سمت لینگوال را سوراخ می‌کنند.

۳۹.گزینه الف

درگیری فضای زیرزبانی در آنژین لودویک موجب بالا آمدن زبان می‌شود که موسوم به woody tongue می‌باشد.

۴۰. گزینه د

۴۱. گزینه د

بافت همبند التهابی دیده نمی‌شود.

۴۲.گزینه ب

هیچ علامت کلینیکی ندارد (condensing osteitis)

۴۳. گزینه د

۴۴.گزینه ج

در هر دو اتساع کلینیکی نداریم. Condensing osteosclerosis فاقد حاشیه رادیولوسنت می‌باشد و رادیو اپستی به آپکس دندان متصل است. همیشه در ارتباط با دندان غیر زنده می‌باشد. در Idiopathic osteosclerosis یک حاشیه رادیولوسنت ناحیه رادیو اپک را احاطه نمی‌کند. بیشتر موارد در ارتباط با آپکس ریشه‌های دندان می‌باشد و در موارد کمی مناطق اسکلروز ممکن است به ناحیه بین ریشه‌ای گسترش یابد. هیچ ارتباطی با دندان‌ها ندارد.

Scanned with CamScanner

۴۵.گزینه ب

شایع‌ترین علت پوسیدگی می‌باشد اما عفونت پریو دنتال، شکستگی، buccal bifurcation cyst و عفونت‌های غیر ادونتوژنیک نیز مطرحند.

۴۶.گزینه د

تشکیل استخوان پریوستئال در تمام موارد زیر دیده می‌شود.

osteomyelitis 2) trauma 3) cyst 4) infantile cortical hyperostosis 5) fluorosis 6) avitaminosis 7) hypertrophic osteoarthropathy 8) congenital syphilis 9) Ewing sarcoma 10) langerhance cell histiocytosis 11) osteogenic sarcoma.

۴۷.گزینه الف

Denticle در اثر تقابل اپی تلیوم و مزانشیم در پالپ در حال تکامل به وجود می‌آید اکثراً به عاج چسبیده‌اند و در کانال ریشه و اتاقک پالپ در مجاورت فورکیشن دیده می‌شوند.

۴۸. گزینه الف

نمای رادیوگرافی و علائم کلینیک مشابه است اما تصویر میکروسکوپیک در گرانولوم پری اپیکال بافت جوانه‌ای التهابی حاوی لنفوسیت می‌باشد و در کیست پری اپیکال حفره کیست با اپی تلیوم سنگفرشی مطبق مفروش گشته است.

۴۹.گزینه د

گاهی در اپی تلیوم کیست رادیکولار کلسیفیکاسیون خطی یا کمانی موسوم به Rushton body دیده می‌شود.

۵۰. گزینه ج

۵۱. گزینه ب

نمای هیستوپاتولوژیکی مشابهی در ضایعات فکی مانند chronic nonbacterial osteomyelitis، CRMO ، SAPHO ، SCCH و chronic tendoperiostitis دیده می‌شود. پرولیفراسیون پریوستئال، ترابکول های نازک استخوانی موازی و متصل به هم را با نوارهای بینابینی بافت همبند شل نشان می دهد. نواحی مدولاری با ترابکول های منحنی(curvilinear) نازک از استخوان woven پر سلول با استرومای فیبروبلاستیک هیپوسلولار پر شده است. این نواحی را می توان به راحتی با دیسپلازی فیبری نابالغ اشتباه گرفت.

Scanned with CamScanner